★★★腹部损伤（0~3题）

- 最常见 - 脾损伤“开干、其他都是屁”（2012）
  - 左上腹外伤、左膈肌抬高
    出血多（Hb ↓、早期休克、移动性浊音）、腹膜炎早而轻（2011、2012）
  - ①脾修补或切除、同时抗休克（2017）
    ②＜ 6 岁：若切脾后可自体脾片移植（避免肺炎链球菌感染为主的 OPSI，2017）
    ③可行回收式自体输血（回输浓缩红）
  - 延迟性脾破裂（2012、2021、2025）—— 预防：绝对卧床＞ 1 周
- 肝损伤（2024）
  - 右上腹外伤、右膈肌抬高
    出血多、腹膜炎早而重（明显腹膜刺激征 - 压痛 / 反跳痛 / 肌紧张，2007、2017）
  - ①肝修补、同时抗休克
    ②大量活动性出血：阻断肝十二指肠韧带止血 / 门管三联入肝血流阻断法
- 空回肠损伤（2022）
  - 中下腹外伤（脐周为著）、出血少、腹膜炎早而重、可有肝浊音界缩小消失
  - 肠修补或切除吻合
- 十二指肠 2/3 部损伤
  - 出血少、睾丸痛、阴茎异常勃起
  - 腰大肌轮廓模糊、腹膜后积气呈花斑样
    腹膜后 / 右肾间隙 / 肠系膜根部气泡（2014、2018）
- 胰腺损伤
  - 多见于方向盘 / 车把伤（概率仅 1%~2%）
  - 腹穿淀粉酶明显高，可有假性囊肿（左上腹包块）

腹膜炎晚而重
疼痛局限在腰背部或上腹部
可伴腹膜后血肿

- 结肠损伤
  - 出血少、腹膜炎晚而重、可有肝浊音界缩小消失
  - ①少数污染轻（多为右半结肠损伤）→一期肠修补或切除吻合
    ②大多污染重（多为左半结肠损伤）→造口或外置、3~4 周后处理